



Este material tem caráter exclusivamente educativo e informativo, não substituindo uma consulta médica individualizada. **É expressamente incentivado o compartilhamento gratuito deste arquivo na íntegra com famílias, educadores e terapeutas**, sendo vedada sua comercialização ou alteração sem autorização prévia.

Para acessar e-books gratuitos, artigos, agendamentos e outros materiais:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O ECOSSISTEMA



ENVIAR O LINK DESTE MATERIAL

© 2026 Dr. Mauro Reis · Versão 1 · setembro de 2026



Como será o futuro do meu filho?



⊕ Como médico...



Como pai... 🏠

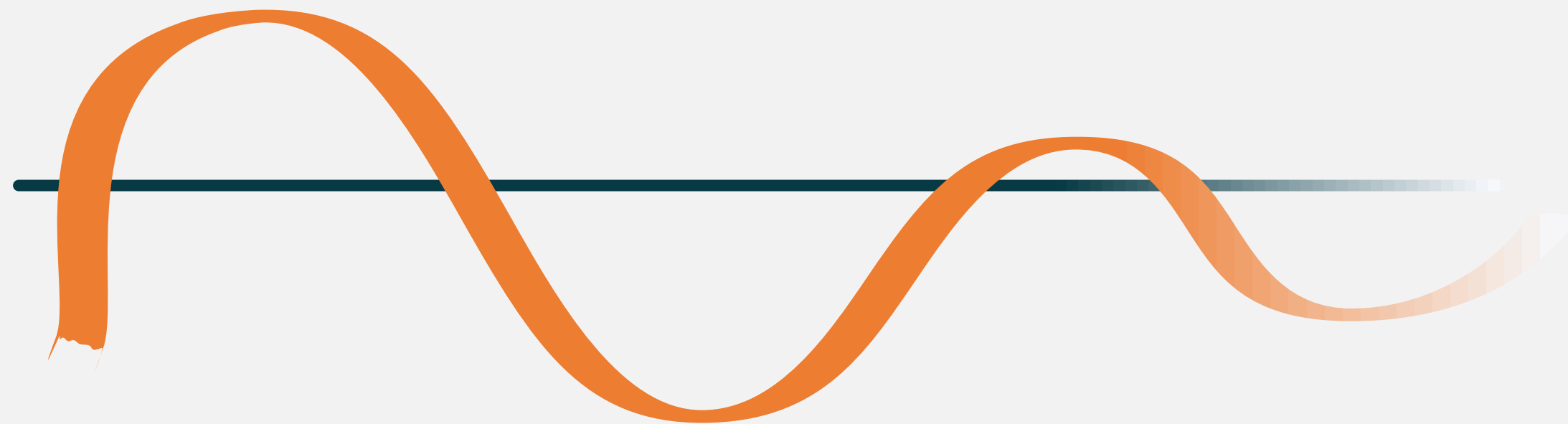


O autismo diminui?

O autismo diminuiu?

O que muda e quando muda?

O que muda e quando muda?



NÚCLEO DO AUTISMO

Comunicação social e comportamentos restritos e repetitivos **tendem a ser estáveis.**

NECESSIDADE DE SUPORTE

Oscila ativamente com estímulos, como a intervenção, o ambiente e o desenvolvimento.

Mudar de gravidade é comum

Mas **quanto** muda depende de quem você mede

Proporção varia dependendo
da coorte e do instrumento utilizado



A mudança é **predominantemente de redução**, mas ocorre nos dois sentidos, e em subdomínios diferentes na mesma criança.

A mudança acontece por subdomínio

COMPORTAMENTOS RESTRITOS

COMUNICAÇÃO SOCIAL

A mudança acontece por subdomínio

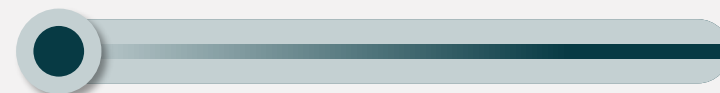
| COMPORTAMENTOS RESTRITOS

Movimentos e fala estereotipados



Reduz o flapping, mas mantém a ecolalia

Interesses restritos



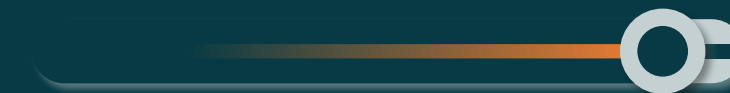
O interesse segue igualmente intenso

Reatividade sensorial



Passa a tolerar o barulho do refeitório

Insistência em rotina



Passa a tolerar mudança de trajeto sem crise

A mudança acontece por subdomínio

| COMUNICAÇÃO SOCIAL

Reciprocidade socioemocional



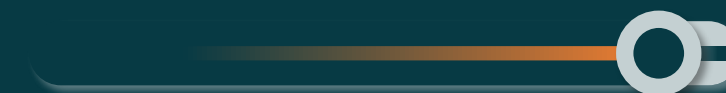
Passa a chamar o adulto para mostrar algo, mas ainda não responde quando é chamado

Comunicação não-verbal



Passa a apontar, olhando para o objeto e para o adulto

Relações



Passa a brincar junto com colegas, e não mais em paralelo

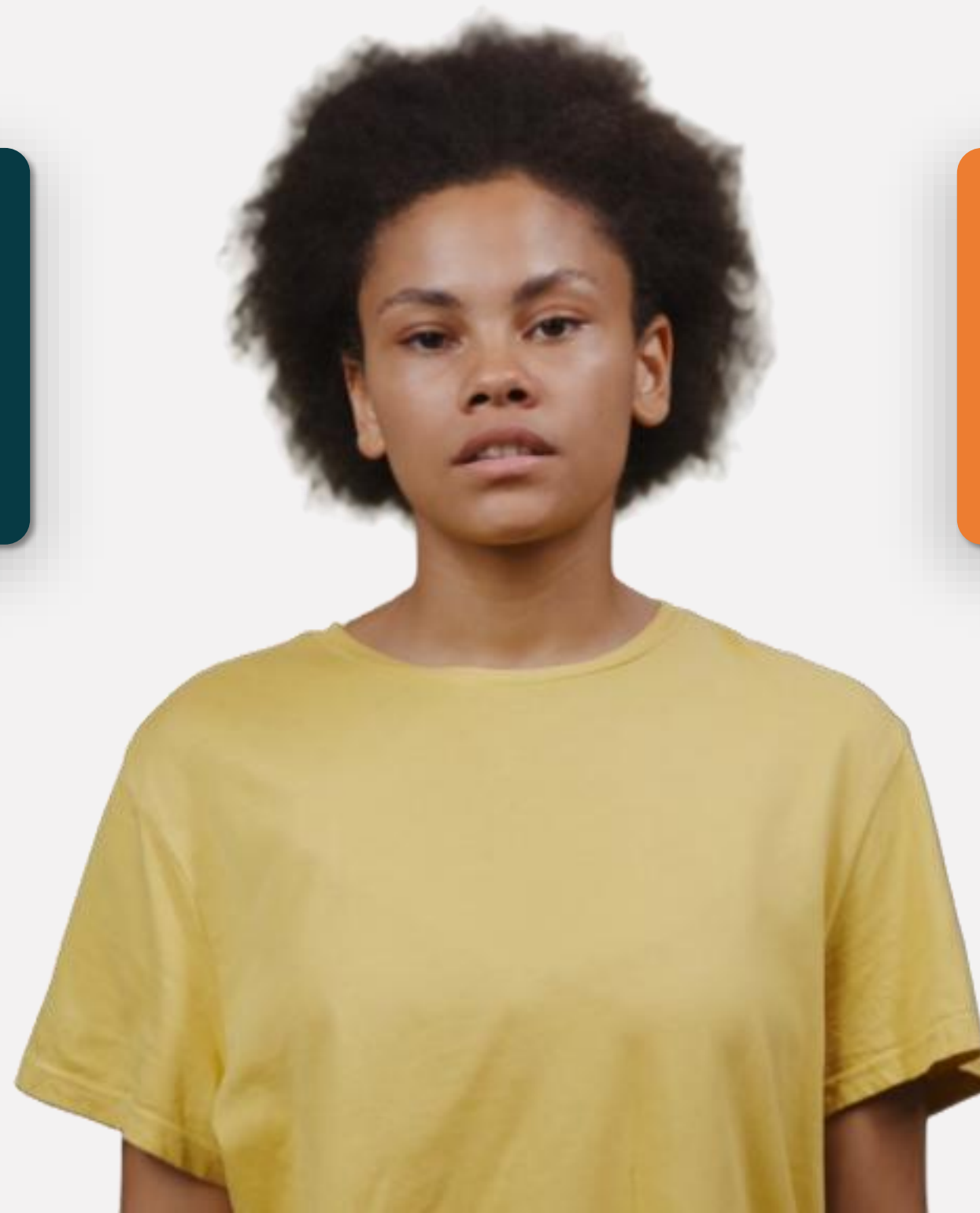
O que diz o DSM-5-TR

O nível é uma fotografia de um momento

Não uma medida de gravidade

COMPORTAMENTOS
RESTRITOS

Nível 1



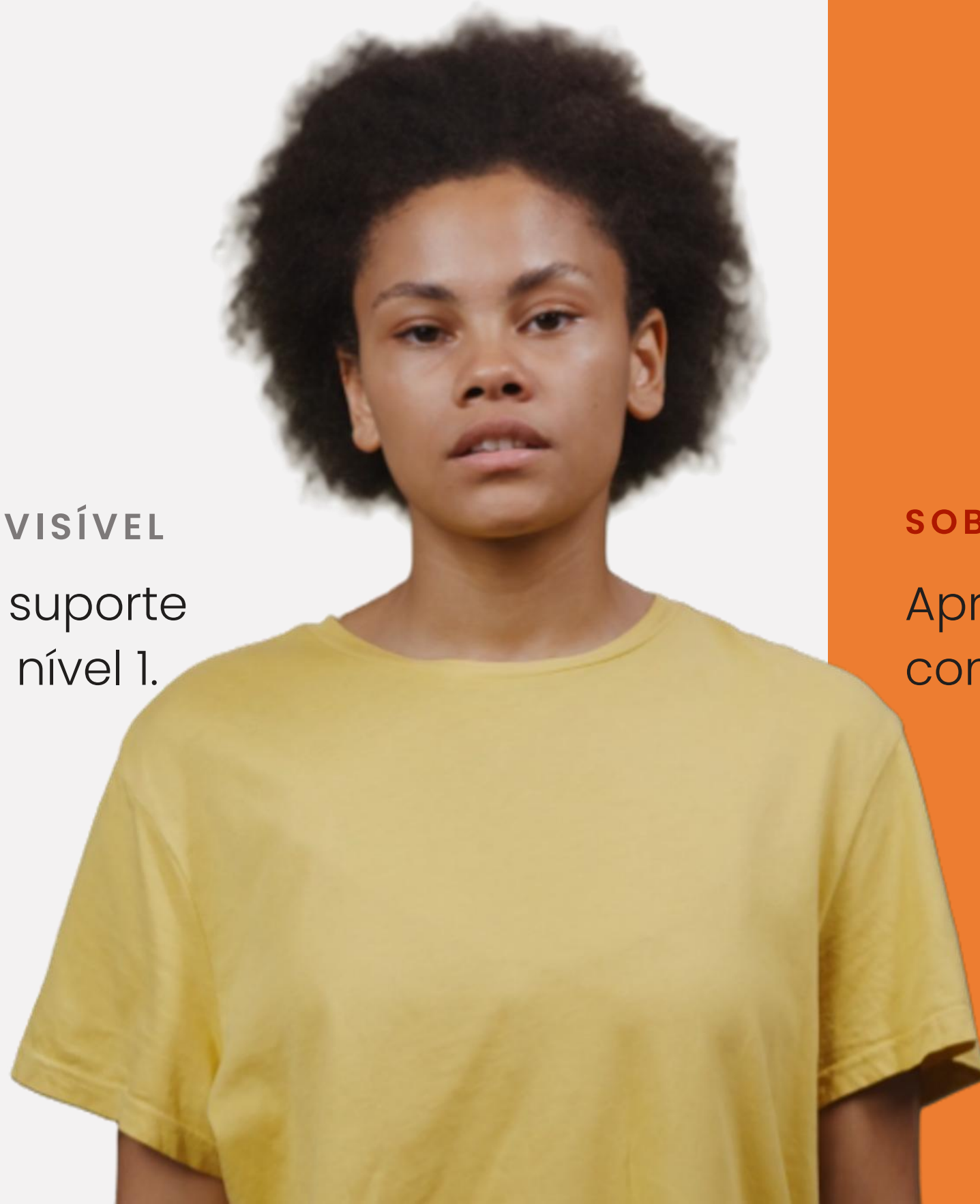
COMUNICAÇÃO SOCIAL

Nível 2

O nível muda quando

EM AMBIENTE PREVISÍVEL

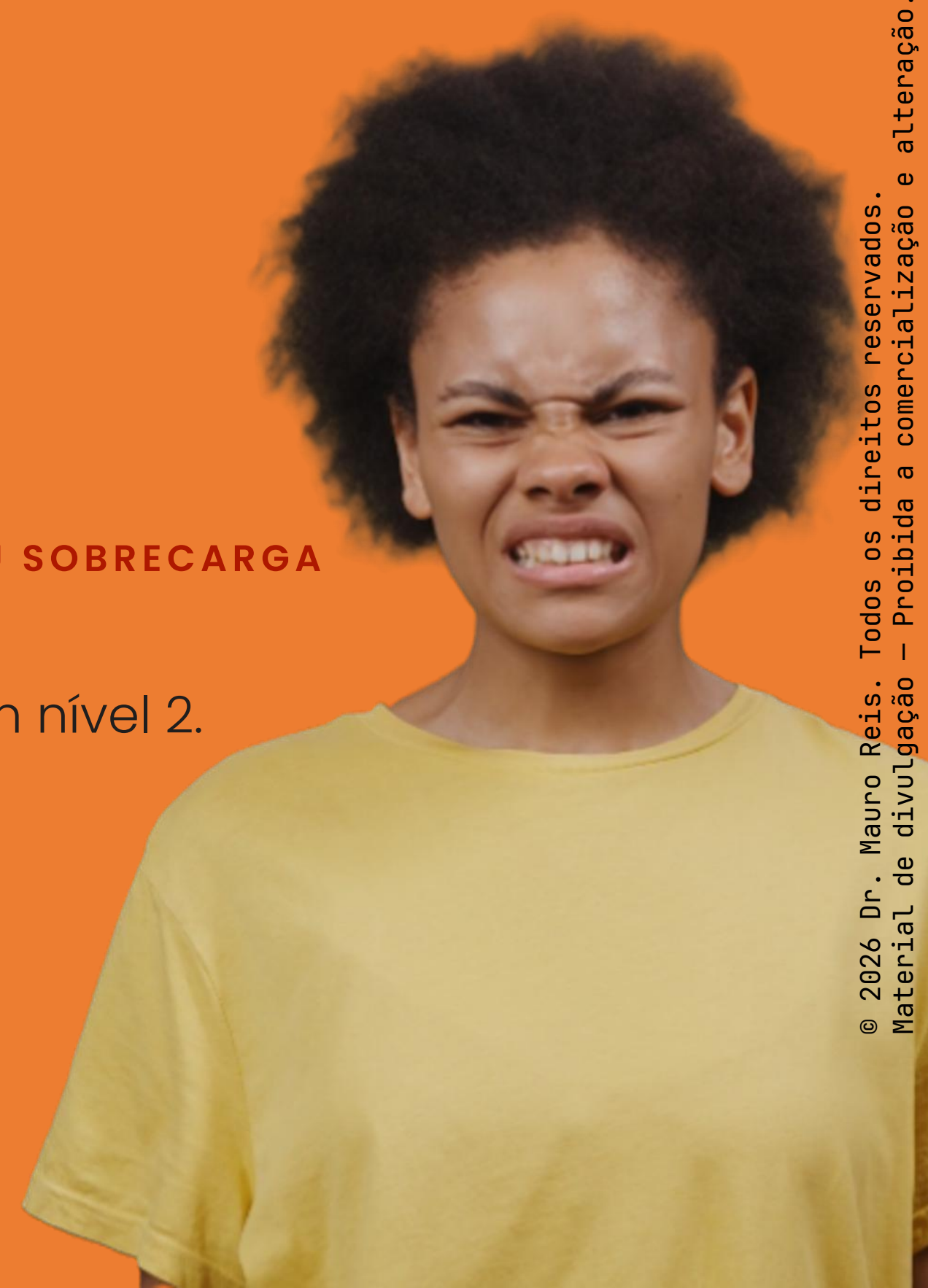
Necessidade de suporte
compatível com nível 1.



o contexto muda

SOB ESTRESSE OU SOBRECARGA

Apresentação
compatível com nível 2.



Os pilares da mudança

Por que as trajetórias divergem?

Cinco fatores ajudam a explicar



Fatores
biológicos

Repertório
inicial

Qualidade da
intervenção

Família e
ambiente

Acesso e
continuidade

A genética pode indicar o **prognóstico**.

QUANDO A INVESTIGAÇÃO GENÉTICA É COMPLETA

◀ **75%**

dos casos seguem sem
causa genética identificada



▶ **25%**

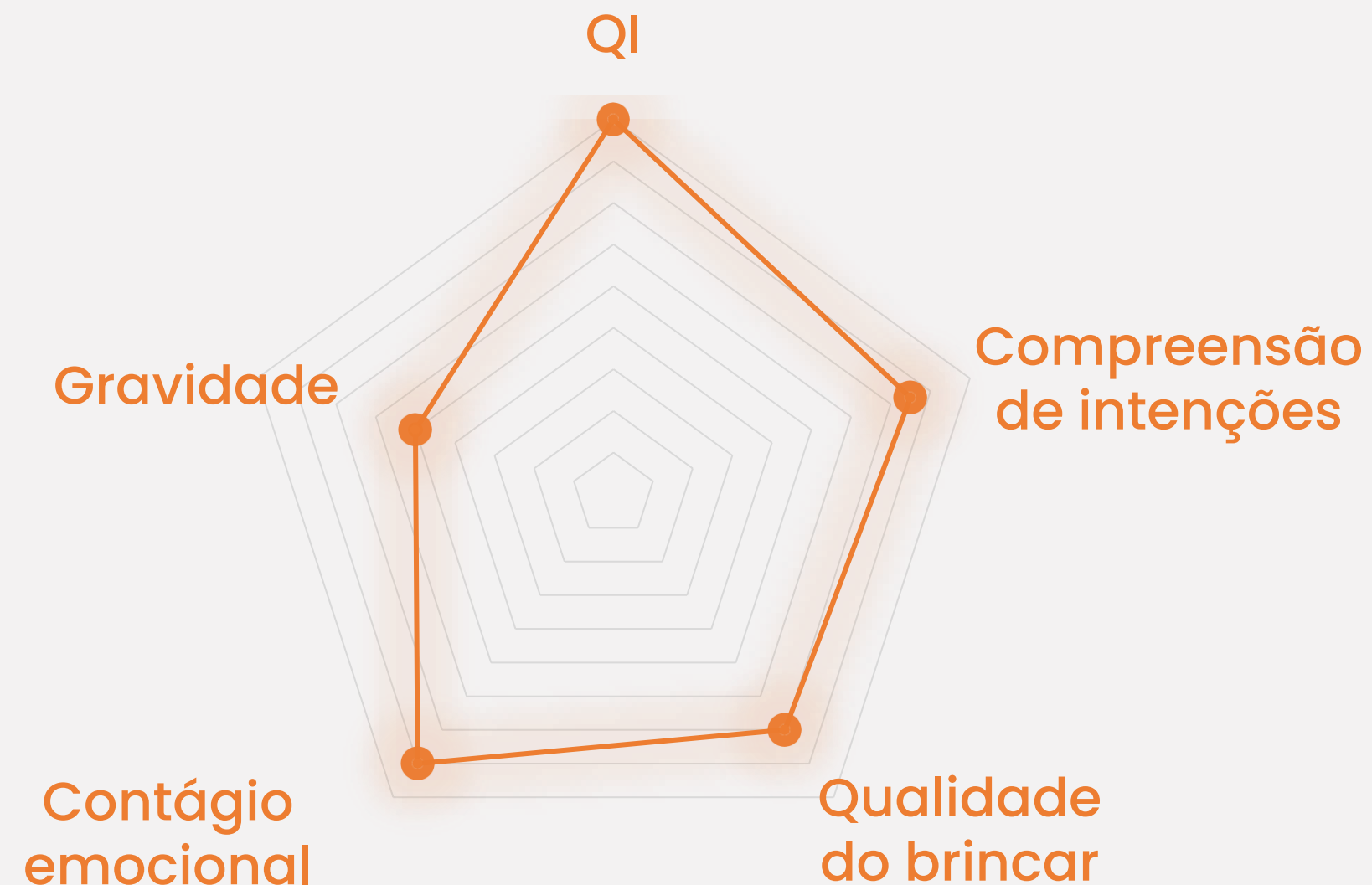
tem causa genética identificada
(ex: Síndrome do X Frágil)

Nesta parcela, o prognóstico estrutural é diferente:

linguagem menos desenvolvida, cognição não-verbal e QI mais baixos, e menos habilidades adaptativas.

Fatores
biológicosRepertório
inicialQualidade da
intervençãoFamília e
ambienteAcesso e
continuidade

○ ponto de partida influencia



QI mais alto, **menor gravidade**, mais **compreensão de intenções**, mais **contágio emocional** e melhor **qualidade do brincar** formam o perfil mais comum de quem deixou de atender critérios no longo prazo.

A cada fator a mais presente no **diagnóstico**, a probabilidade de desfecho favorável aumenta.

**Mas nenhum fator isolado decide.
Preditor não é destino.**

Fatores
biológicos

Repertório
inicial

Qualidade da
intervenção

Família e
ambiente

Acesso e
continuidade

Perfis diferentes respondem melhor a abordagens diferentes



João

QI mais alto
na entrada do
tratamento

**ABA
ESTRUTURADO (EIBI)**



Bela

Melhores habilidades
sociocognitivas: intenção
de comunicar, atenção a
rostos, linguagem receptiva

**MODELO
DENVER (ESDM)**

Fatores
biológicos

Repertório
inicial

Qualidade da
intervenção

Família e
ambiente

Acesso e
continuidade

Mais horas **não produzem**, por si só, mais efeito

META-ANÁLISE 2024

144

estudos

9.000

crianças

**Intensidade
diária**

(horas por semana)

Duração

(por quantos meses)

**Intensidade
acumulada**

(horas recebidas totais)

**Nenhuma das três medidas se
associou ao tamanho do efeito.**

Fatores
biológicos

Repertório
inicial

Qualidade da
intervenção

Família e
ambiente

Acesso e
continuidade

Mais horas **não produzem**, por si só, mais efeito

Objetivos
individualizados
e assertivos



Fidelidade e
habilidade de
quem aplica



Engajamento
familiar
consistente



MAIOR EFEITO



Fatores
biológicosRepertório
inicialQualidade da
intervençãoFamília e
ambienteAcesso e
continuidade

A família como **parte ativa** do cuidado

EFEITO DAS INTERVENÇÕES CONDUZIDAS PELOS PAIS, POR DOMÍNIO

Habilidades sociais e comportamento positivo

Linguagem e comunicação

Comportamento adaptativo



Efeito Maior



Efeito Menor

Além dos ganhos em linguagem e socialização, intervenções de sono conduzidas pelos próprios **pais melhoram o sono da criança**.

E o sono ruim está associado a mais dificuldades de regulação e de comportamento no dia a dia.

Por isso, o sono entra no plano de cuidado, e não como assunto à parte.

Fatores
biológicosRepertório
inicialQualidade da
intervençãoFamília e
ambienteAcesso e
continuidade

A **fila de espera** também é um fator de prognóstico

Primeira
preocupação

~2 anos

Diagnóstico

até + 1 ano

Início da
intervenção

30%

das crianças esperaram mais
de um ano entre o diagnóstico
e o início da intervenção



Fatores
biológicos

Repertório
inicial

Qualidade da
intervenção

Família e
ambiente

Acesso e
continuidade

Por aqui, o acesso também tem **gargalos**



2,4 mi

De pessoas com TEA*
(1,2% da população)

326

Centros Especializados
em Reabilitação no país**
(todas as deficiências)

3 anos

de espera estimada em
Campo Grande/MS, com
quase 2 mil na fila

**A descontinuidade pode interromper o
progresso e dificultar sua manutenção.**

Fatores
biológicos

Repertório
inicial

Qualidade da
intervenção

Família e
ambiente

Acesso e
continuidade



Decisão do STJ

Sobre a limitação imposta por planos de saúde

É **abusiva a limitação** do número de sessões de terapia multidisciplinar (psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia e terapia ocupacional) prescritas ao paciente com Transtorno do Espectro Autista.

Tema 1.295

Os 5 pilares na vida real

L., 3 anos

Preditores aumentam probabilidade, mas não determinam trajetórias individuais.

Vídeo exibido na palestra

No vídeo, a mãe narra dois momentos. No primeiro, identificado como o período com acesso às telas, ele aparece inquieto, com as mãos nos ouvidos e pouca interação com quem está por perto.

No segundo, sem telas, aparece falando, brincando e sustentando atenção nas atividades.

Os pilares da evolução do L.

Fatores
biológicos

1

Sem causa
genética
identificada

Repertório
inicial

2

Linguagem
receptiva
preservada na
base

Qualidade da
intervenção

3

Objetivos
revisados a
cada ciclo,
mesmo volume
de horas

Família e
ambiente

4

Sono
regularizado,
telas retiradas,
família ativa

Acesso e
continuidade

5

Tratamento
sem interrupção
ao longo de
todo o período

Melhora funcional não é deixar de ser autista

3-25%

Deixam de **atender critérios** em reavaliação, ficando na faixa normal em cognição, adaptação e social.

Com vulnerabilidades residuais em comunicação de ordem superior e atenção, mais tiques, depressão e fobias como comorbidades frequentes.

Medimos sucesso por:

Autonomia, habilidades de vida diária, comunicação, relações e atividades fora de casa e não por **“não ser mais diagnosticado”**.

A vida real



O professor(a) como agente de intervenção

Em ambiente escolar, intervenções conduzidas por professores e profissionais da escola produziram **efeitos superiores** às conduzidas por pesquisadores externos.

A diferença está na presença contínua e na familiaridade com o contexto, não na competência de quem entrega.

O que **podemos fazer** na segunda-feira

EDUCADOR(A)

Levar a estratégia para a rotina escolar

A intervenção não termina na sessão: a escola também é espaço para praticar e generalizar habilidades.

Ajustar o ambiente antes que a dificuldade apareça

Antecipar demandas e ajustar o ambiente pode reduzir barreiras à participação e à aprendizagem.

Observar quando e em que contexto o comportamento aparece

A necessidade de suporte pode mudar conforme a demanda, o contexto e as habilidades exigidas.

O que **podemos fazer** na segunda-feira

EDUCADOR(A)

Levar a estratégia para a rotina escolar

Ajustar o ambiente antes que a dificuldade apareça

Observar quando e em que contexto o comportamento aparece

O educador(a) **sustenta o contexto** em que a criança pratica, participa e generaliza habilidades.

Observar esse contexto ajuda o time a individualizar o suporte.

O que **podemos fazer** na segunda-feira

PSICÓLOGO(A) E TERAPEUTA

Escolher a abordagem pelo repertório inicial

QI e habilidades sociocognitivas podem ajudar a identificar qual abordagem tende a favorecer melhor resposta.

Revisar os objetivos conforme a resposta

Mais horas de intervenção não garantem, por si só, melhores resultados. O plano precisa acompanhar a resposta e o progresso da criança.

Medir fidelidade de execução, não só presença

Estar presente não garante que a intervenção esteja sendo aplicada como planejado.

O que **podemos fazer** na segunda-feira

PSICÓLOGO(A) E TERAPEUTA

Escolher a abordagem pelo
repertório inicial

Revisar os objetivos conforme
a resposta

Medir fidelidade de execução,
não só presença

O terapeuta não deve apenas
“entregar horas de terapia”;
precisa observar resposta,
verificar qualidade da
implementação e individualizar
a estratégia.

O que **podemos fazer** na segunda-feira

FAMÍLIA

Participar ativamente da intervenção

Quando treinados para aplicar estratégias, pais podem contribuir para ganhos em habilidades sociais, linguagem e comportamento.

Cuidar da rotina e do sono como parte do tratamento

Crianças que dormem bem apresentam menos dificuldades de regulação e de comportamento no dia a dia.

Questionar limites arbitrários de sessões impostos pelo plano

Tema 1.295/STJ: é abusiva a limitação do número de sessões multidisciplinares prescritas para o tratamento do TEA.

O que **podemos fazer** na segunda-feira

FAMÍLIA

Participar ativamente da
intervenção

Cuidar da rotina e do sono
como parte do tratamento

Questionar limites arbitrários de
sessões impostos pelo plano

A família **não é apenas quem
acompanha o tratamento**. Ela
conecta todos os profissionais,
ajuda a fazer a intervenção
acontecer no cotidiano e
sustenta rotinas.

E o que a família pode
esperar do médico

Rastrear antes da queixa

A Linha de Cuidado de 2025 orienta rastrear sinais de TEA em todas as crianças entre 16 e 30 meses.

E o que a família pode
esperar do médico

Encaminhar na primeira **preocupação, não na certeza**

A intervenção não depende do laudo definitivo.
Diante de atrasos no neurodesenvolvimento, o
encaminhamento para terapias deve ocorrer
em paralelo à investigação diagnóstica.

E o que a família pode
esperar do médico

Investigar causa quando há indicação

Identificar uma etiologia pode qualificar o
prognóstico, o aconselhamento familiar e o
acompanhamento de condições associadas

E o que a família pode
esperar do médico

Tratar o que atrapalha o **aprendizado**

Sono ruim, epilepsia e dificuldades de atenção podem interferir na participação, no aprendizado e no aproveitamento da intervenção

E o que a família pode
esperar do médico

Descrever o suporte por domínio no laudo

O DSM-5-TR prevê níveis de suporte para cada domínio. Um único nível pode esconder necessidades diferentes.

E o que a família pode
esperar do médico

Prescrever conforme a necessidade clínica e sustentar a prescrição

Tema 1.295/STJ: é abusiva a limitação, pelo plano, do número de sessões multidisciplinares prescritas para o tratamento do TEA.

Cinco pilares. Quatro papéis. Um único time.

Médico

Rastreio, investigação, comorbidades e plano de cuidado

Terapeuta

Objetivos, qualidade da execução e ajuste ao repertório

Educador

Estratégias na rotina, ambiente e observação

Família

Participação, rotina, sono e conexão com o time

O desenvolvimento acontece quando essas partes se conectam.

A pergunta não é
se ele vai **deixar**
de ser autista.

É de quanto **suporte** ele
vai precisar e o quanto
disso depende de nós.

Como será o futuro dos nossos filhos?

Conecte-se
Dr. Mauro Reis
CRM 52 1152653



Acesse o
ECOSSISTEMA



pdf_palestra_autismomuda

[CLIQUE AQUI PARA ACESSAR](#)



Este material tem caráter exclusivamente educativo e informativo, não substituindo uma consulta médica individualizada. **É expressamente incentivado o compartilhamento gratuito deste arquivo na íntegra com famílias, educadores e terapeutas**, sendo vedada sua comercialização ou alteração sem autorização prévia.

Para acessar e-books gratuitos, artigos, agendamentos e outros materiais:



CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O ECOSSISTEMA



ENVIAR O LINK DESTE MATERIAL

© 2026 Dr. Mauro Reis · Versão 1 · setembro de 2026